EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81774
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-02 11:58:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: INADINA DE LA ROSA VALENZUELA BELMAR			**RUN**	: 6.454.659-7
F.Nac	: 29-06-1943	**Edad**	: 80 AÑOS, 9 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: ARIZONA SAN LUIS			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 979754100		
Fecha Ingreso	: 2024-03-27	**Fecha Egreso**	: 2024-04-02 11:58:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1- Neumonia ATS III
2- Infección Del Tracto Urinario Bajo: Cistitis
3- HTA Sistemica
4- ERC Reagudizada (creat basal 1.6- 1.8)
5- DM2NIR mal controlada HBA1C 11.3
6- Anemia Normocitica Normocromica
7- DLP

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Femenina Con Antecedente De Hta Sistemica, Dmnir, Erc Quien Refiere Inicio De Cuadro Clínico Hace 1 Mes Caracterizado Por Tos Seca Asociado A Disnea Y Compromiso Del Estado General Por Lo Que Es Traida Al Su Hsc Donde Paciente Ingresa Taquipneica Con Requerimientos De Fio2, Solicitan Laboratorios Que Objeitva Parametros Inflamatorios Elevados, Incremento De Creatinina Basal Y Dimero D Elevado Por Lo Que Realizan Angiotac Torax No Mostrando Hallazgos Sugestivos De Tep Y Scanner Abdomen Pelvis Que Demustra Signos Compatibles Con Cistitis Aguda, En Vista De Permanecer Con Requerimientos De Fio2 . con buena evlucion clinica , en estables condiciones, quejumbrosa, sin disnea ni compromiso ventilatorio, sin necesidad de o2 suplementario; afebril, hidratada, persiste con dolor lumbar de tipo radicular Piel con Moderada palidez cutaneo mucosa, mucosa oral humeda, bien perfundida Torax hipo expansible con crepitantes bilaterales, RsCsRs NAS Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal, RH+ Extremidades: simétricas, sin edema ni signos de TVP Neurológico vigil orientad , Glasgow 15 ptos. Parámetro inflamatorios a la baja. En condiciones de Alta.

PLAN DE MANEJO:

Hospitalización domiciliaria
Exámenes control para mañana
Vigilara elp y crea diaria

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Régimen liviano para diabeticos, hiposodico con aporte de agua oral 1.5lts
3. KNT Respiratoria y Motora
4. Ertapenem 1gr dia ev
5. B. Ipratropio 4puff cada 6hrs
6. Brexotide 2 puff cada 12hrs
7. Lab control sábado 30/3/24 con residente de turno
8. Medicamento Indicacion Hora Funcionario
9. Omeprazol 20 mg dia vo
10. Paracetamol 500 mg 2 comp cada 8 horas sos dolor vo
11. Hidrtazina Comp 50mg cada 8 hrs vo
12. Fluticasona/Salmeterol Inhalador 250 Microgramos / 25 Microgramos 1 Inhalador Cada 24 Hrs.

OBSERVACIONES:

Control por APS

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO